RELATÓRIO DE PESQUISA · 2026

Alopecia, TOC e saúde mental em homens jovens

Queda de cabelo aos 30, o hábito de passar a mão no cabelo e o impacto na autoestima e no humor

Material informativo. Não substitui avaliação médica ou psicológica.

A mensagem central em quatro pontos

01

Calvície aos 30 é comum

Entre 1 em 3 e 1 em 2 homens dessa idade já têm algum grau de alopecia androgenética.

02

O gesto é o problema maior

Esfregar o cabelo a cada minuto quebra fios, fere a pele e aponta para o espectro obsessivo-compulsivo.

03

Tratar o ciclo vem primeiro

Terapia de reversão de hábito e TCC têm a melhor evidência. O transplante deve esperar.

04

Finasterida pede cautela

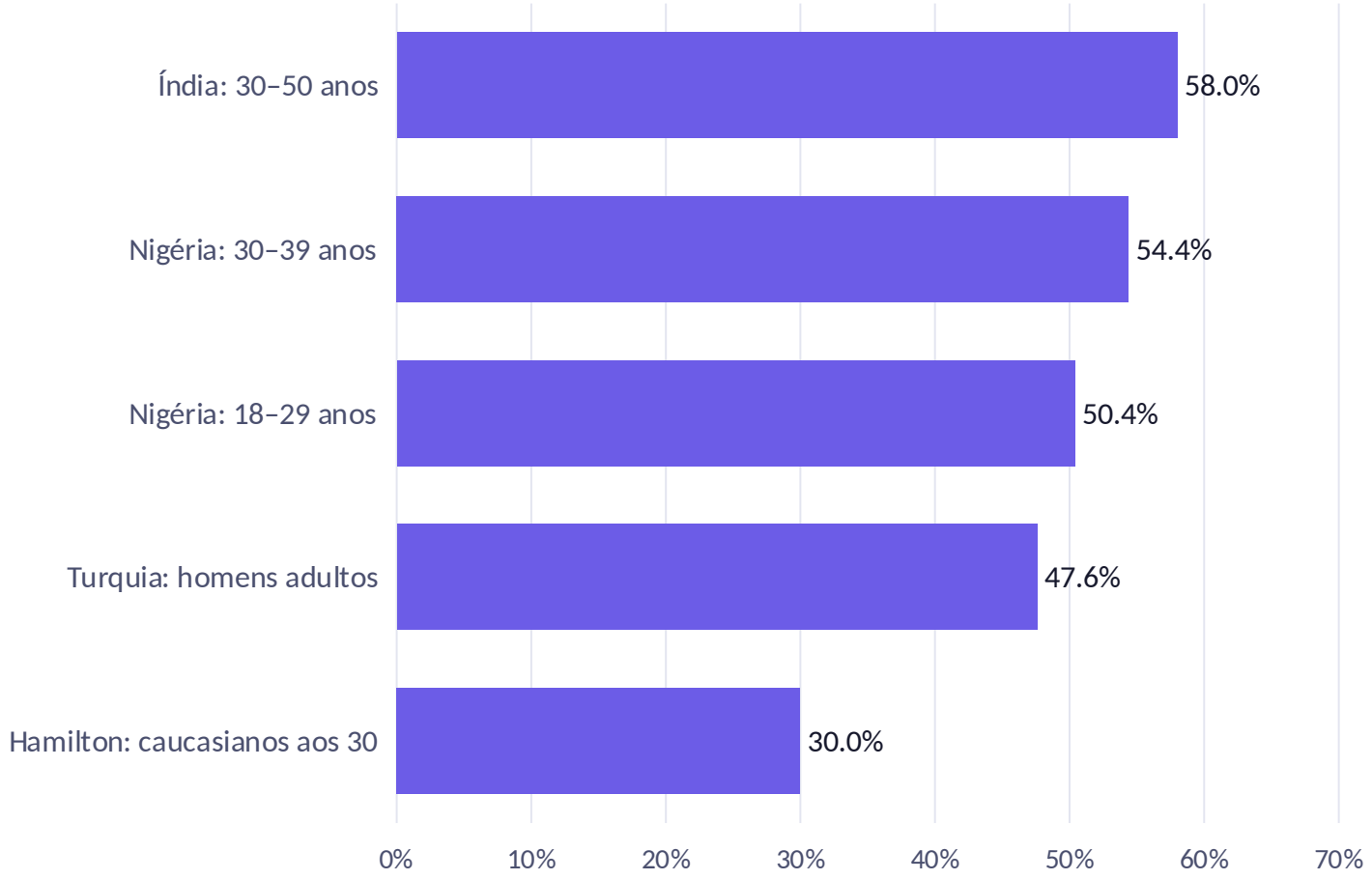
EMA e ANVISA (2025) listam ideação suicida e depressão como possíveis efeitos.

PARTE 1

Calvície aos 30 anos

Frequência, sinal de alerta metabólico e diagnóstico diferencial

Ter entradas aos 30 é estatisticamente comum



1 em 3

a 1 em 2

homens perto dos 30 anos já têm algum grau de calvície de padrão masculino.

Estudos mais recentes incluem graus leves e por isso encontram números mais altos que o clássico 30%. Não há dados brasileiros robustos por idade.

Fontes: An Bras Dermatol/SciELO; Nigerian J Dermatol; PMC2938575; Ann Dermatol.

Quando começa cedo, olhe também o metabolismo

3,5×

mais chance de síndrome metabólica em pessoas com alopecia androgenética

OR 3,46 (IC95% 2,38–5,05) · 2.531 participantes · associação mais forte no início precoce

Rastreio barato e coerente com a evidência

- **Pressão arterial**
- **Circunferência da cintura**
- **Glicemia**
- **Colesterol e triglicerídeos**

Em homens com menos de 35 anos, outra meta-análise encontrou perfil de glicose e lipídios levemente pior.

Fontes: Acta Derm Venereol 2022; Sci Rep 2017.

Nem toda queda aos 30 é calvície

Alopecia androgenética

Entradas e topo, progressiva, ligada ao DHT

Eflúvio telógeno

Queda difusa 2–3 meses após estresse, doença ou dieta. Reversível

Alopecia areata

Autoimune, em placas. Maior peso psiquiátrico

Tricoteiromania

Quebra por esfregar ou coçar repetidamente

Tricotilomania

Arrancar os fios. Espectro obsessivo-compulsivo

Tinea e outras

Micose do couro cabeludo, doenças reumatológicas

Como se diagnostica

- História e padrão da perda
- Teste de tração
- Tricoscopia do couro cabeludo
- TSH, hemograma e ferro
- Biópsia só em casos atípicos

8,5%

de 1.411 pacientes com queda tinham disfunção da tireoide

Fontes: Cleve Clin J Med 2026; JAAPA 2026; Skin Appendage Disord 2021; J Clin Aesthet Dermatol 2026.

PARTE 2

A mão no cabelo a cada minuto

O que pode estar por trás do gesto e o dano que ele causa

15 min

de fricção já bastam para quebrar o cabelo. Repetido o dia todo, vira trauma contínuo.

O mesmo gesto, motivos diferentes

	O que move o gesto	Hipótese mais provável	Pistas
	Medo de ficar mais calvo, "conferir a densidade"	**Transtorno dismórfico corporal (TDC)**	Espelho, fotos, bonés, pedir confirmação a outros ou a médicos
	Alívio, hábito automático, tédio, estresse	**BFRB / tricoteiromania**	Faz sem perceber e sente alívio
	Medo não estético ou sensação de "não estar certo"	**TOC de checagem**	Rituais em outras áreas da vida
	Coceira intensa que leva a coçar	**Líquen simples crônico**	Placas espessadas, crostas

As hipóteses podem coexistir. Só um profissional consegue dizer qual se aplica.

O atrito deixa marcas visíveis na tricoscopia

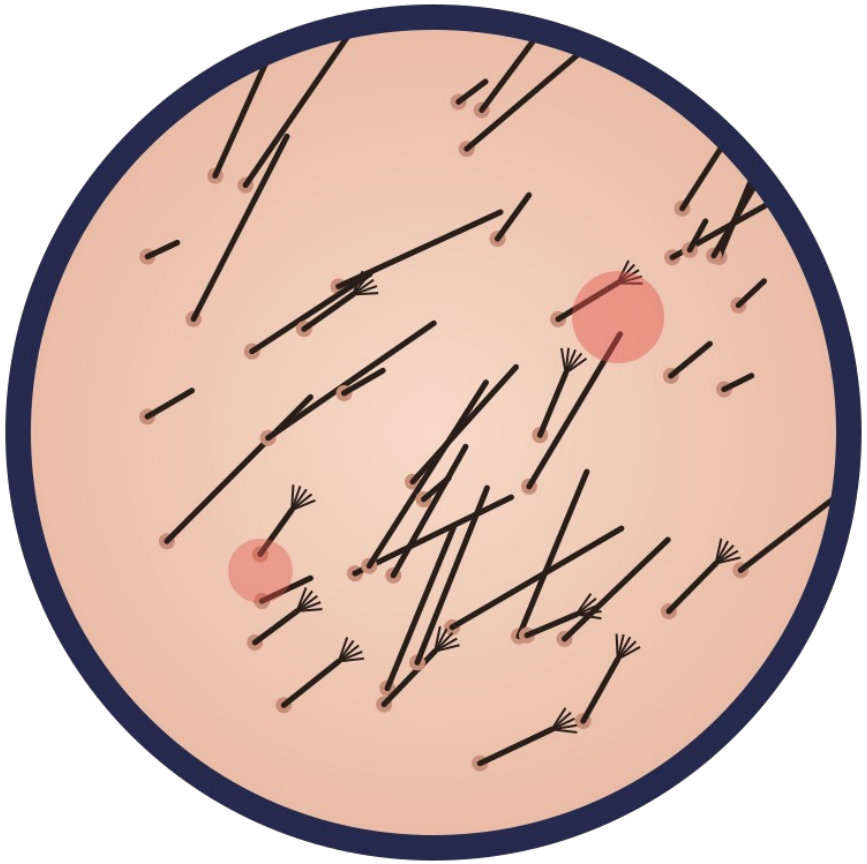


Ilustração esquemática

- **Pelos "em vassoura"**

  Pontas desfiadas pela fricção

- **Fios quebrados em alturas diferentes**

  Também pelos em V

- **Descamação, vermelhidão e crostas**

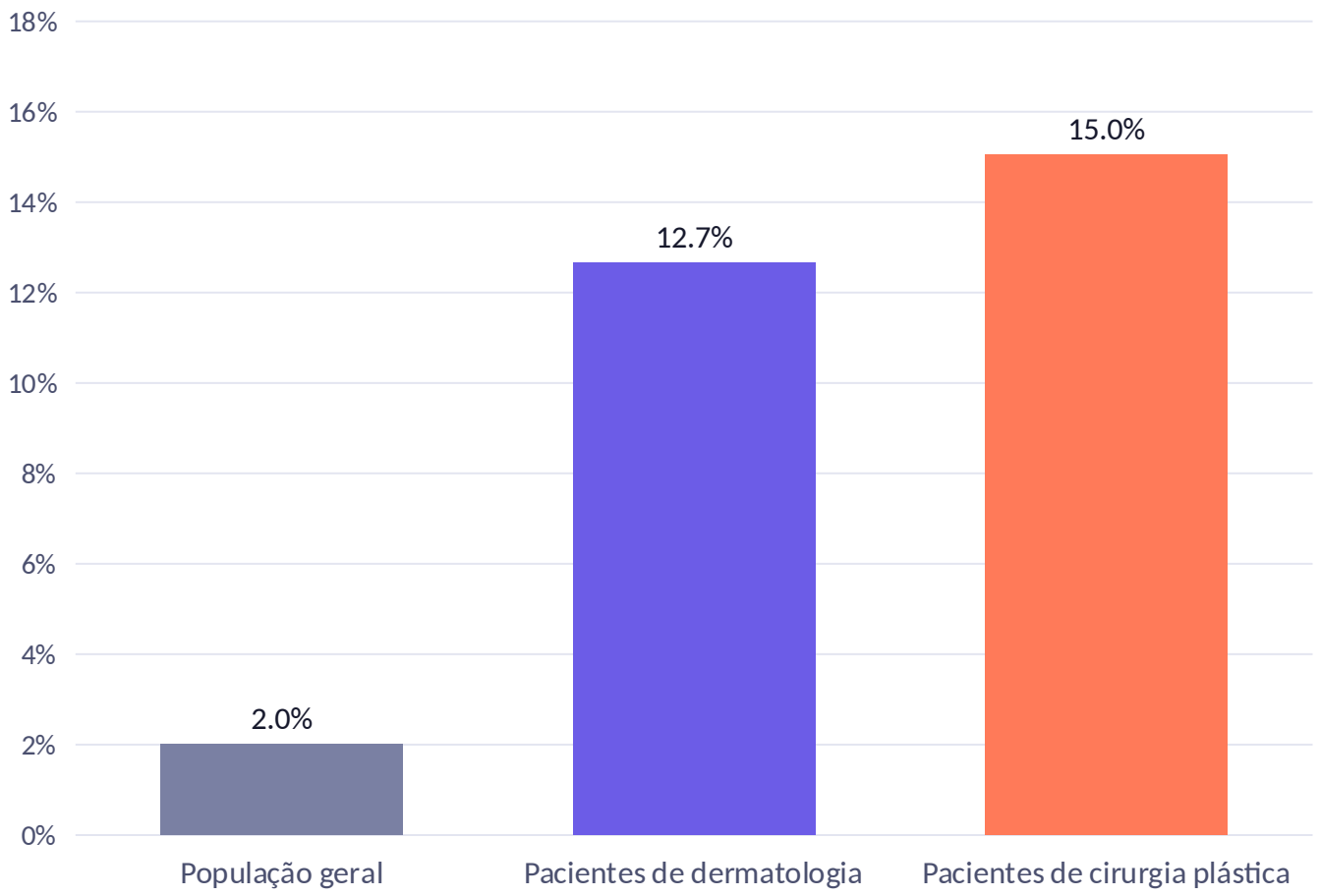
  Quando há coçadura e escoriação

- **Tende a ser reversível**

  A quebra por atrito regride quando o gesto para

Fontes: Bhat 2025; Corona-Rodarte 2026; Trüeb 2025; Sánchez-Dueñas 2021 (três homens com calvície e tricoteiromania).

O TDC é muito mais comum no consultório



Homens se fixam mais na calvície

Num estudo com 200 pessoas com TDC, "cabelo ralo/calvície" era foco mais comum nos homens

Risco de suicídio considerável

O TDC afeta cerca de 2% dos adultos e pesa sobre o funcionamento e o trabalho

Triagem simples existe

Questionário BDDQ-DV: 100% de sensibilidade e 93% de especificidade (estudo pequeno)

Fontes: Ribeiro 2017 (meta-análise de 33 estudos); Phillips, Menard & Fay 2006; Rück 2024; Dufresne 2001.

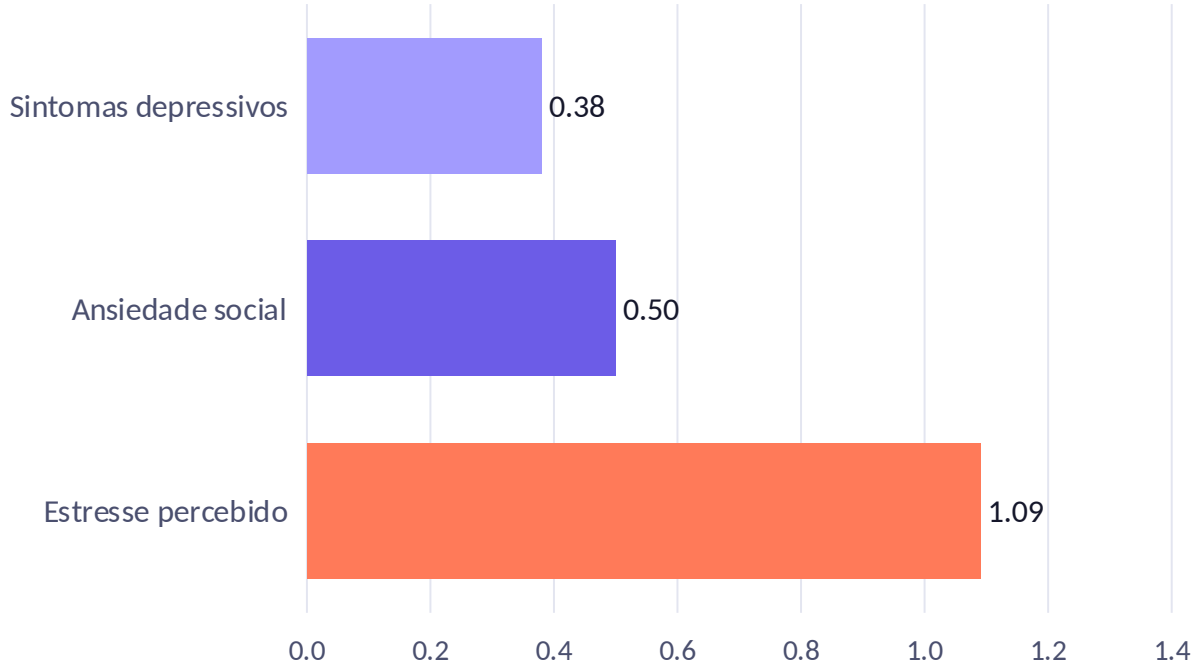
O círculo vicioso da checagem



Fontes: Tan & Jafferany 2025; Toh et al. 2025; Trüeb 2025.

Na calvície, o peso cai mais sobre a autoestima

Diferença em relação a controles (SMD), meta-análise de 2025



Qualidade de vida: impacto moderado (DLQI médio 8,16). Depressão clínica não aumenta na maioria dos homens.

Quem sofre mais

- Início antes dos 20 anos
- Perda percebida como grave
- Homens jovens e solteiros
- Preocupação dismórfica

Um gesto que fere o couro cabeludo a cada minuto já indica sofrimento desproporcional.

Fontes: Kong 2025; Huang, JAMA Dermatol 2021; Frith & Jankowski 2023; Acta Derm Venereol 2023.

Na alopecia areata, o risco psiquiátrico é maior

>1/3

dos pacientes têm sintomas depressivos ou ansiosos relevantes

7–17%

têm transtornos que pedem tratamento psiquiátrico

6,3×

risco de tentativa de suicídio numa coorte de Taiwan (estudo único)



3,6 anos mais jovens

Os mesmos homens, depois de um transplante, foram vistos como mais jovens, atraentes e bem-sucedidos. A percepção social é real, mas não há bons dados sobre emprego ou relacionamentos.

Fontes: Lauron, JAMA Dermatol 2023; Dermatology 2023; Bater 2016.

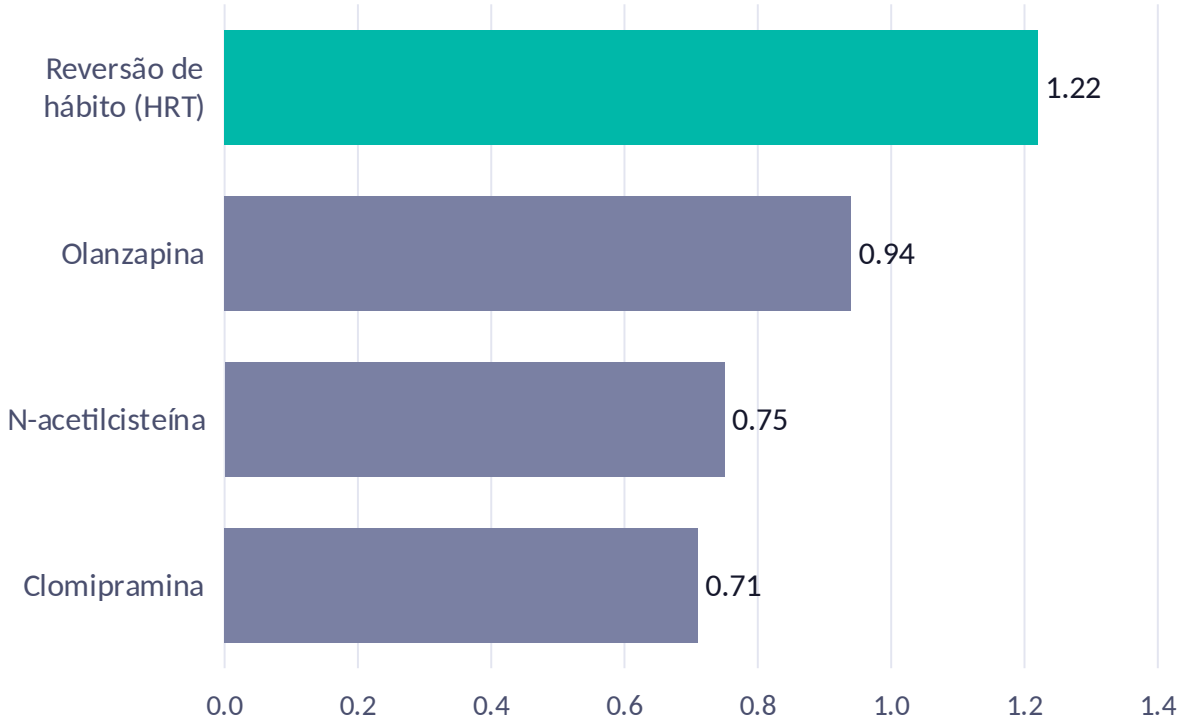
PARTE 3

O que funciona

Primeiro o comportamento, depois a queda, com cautela na medicação

Terapia de reversão de hábito lidera a evidência

Tamanho de efeito vs. placebo (|SMD|), 24 ensaios em tricotilomania



Remédios: apoiados em estudos isolados, nenhum aprovado para isso. N-acetilcisteína: 56% vs 16% com placebo, a partir da 9ª semana (amostra quase toda feminina).

Como a HRT funciona

1 **Perceber**

Notar quando a mão vai ao cabelo e o que dispara o gesto

2 **Resposta incompatível**

Fechar as mãos ou tensionar os braços por cerca de um minuto

3 **Apoio social**

Alguém de confiança reforça o progresso

Novos modelos (ComB, ACT, DBT) e autoajuda com "decoupling" também mostraram benefício.

Fontes: Farhat 2020; Grant 2009; TLC Foundation; IOCDF; Murase 2025.

Se for checagem, o caminho é TCC com ERP

Exposição e prevenção de resposta

Aprender a não checar, não pedir confirmação e reduzir o espelho

ISRS em dose mais alta

O TDC costuma exigir doses maiores e tentativas de 12 a 16 semanas

Efeito grande nos dois

Sintomas depressivos do TDC: ISRS SMD −1,16; TCC −1,12

Dizer "para de mexer" não funciona. Funciona tratar como sintoma e encaminhar.

O transplante deve esperar

64% das pessoas com TDC fizeram tratamentos estéticos, que raramente melhoraram o transtorno

- Aos 30 anos o padrão final da calvície pode não estar definido
- Estabilizar a queda com tratamento clínico por pelo menos 12 meses
- Controlar o hábito de esfregar, que também lesaria os enxertos

Fontes: Rück 2024; Geho 2026; Loewen 2026; PMC9063569; Crerand 2005; Gumma 2026.

Opções para a queda em si

Opção	Evidência principal	Segurança
Finasterida 1 mg oral	Melhor oral aprovada; com minoxidil é a combinação mais eficaz em homens	**Alerta EMA/ANVISA 2025: humor, depressão, ideação suicida, efeitos sexuais**
Finasterida tópica 0,25%	+20,2 vs +6,7 fios em 24 semanas, próxima da oral	Nível no sangue >100× menor; FDA alertou sobre versões manipuladas
Minoxidil oral em dose baixa	5 mg não inferior ao tópico em ensaio brasileiro	Pelos no corpo; sem efeitos psiquiátricos relatados
Dutasterida 0,5 mg	A mais eficaz nas meta-análises em rede	Off-label para queda; incluída no alerta da ANVISA
Clascoterona 5% tópica	Fase 3 positiva	Ainda não aprovada; registro previsto para 2027
PRP e lasers	Ganhos modestos de densidade	Adjuvantes, evidência heterogênea

Fontes: J Cosmet Dermatol 2024/2025; Front Med 2025; JEADV 2022; AAFP 2025; JAAD 2021; Skin Appendage Disord 2026.

Finasterida: como o alerta se formou

2012

Publicidade sobre a "síndrome pós-finasterida" aumenta as notificações

2022

FDA inclui alerta de suicídio na bula do Propecia

Abr 2025

FDA alerta sobre finasterida tópica manipulada

Mai 2025

EMA confirma ideação suicida como efeito adverso

Jun 2025

ANVISA publica o Alerta GGMON nº 7/2025

Ago 2025

Decisão final da União Europeia; cartão para o paciente

3,47

ROR de suicidalidade em homens ≤45 anos (VigiBase)

3–4 meses

tempo médio até os sintomas aparecerem

Pare e procure

orientação oficial se surgir humor deprimido

Fontes: EMA/PRAC 2025; ANVISA Alerta GGMON 7/2025 (via repost); FDA 2025; Nguyen, JAMA Dermatol 2021; Lee 2025.

Por que a evidência parece se contradizer

Bases de notificação

Sinal forte

- Concentrado em homens de 18 a 45 anos que tratam queda
- Sem sinal em homens mais velhos tratados para próstata
- Limite: infladas por publicidade; não medem incidência

Grandes coortes

Mais depressão, sem mais suicídio

- Suécia, 2,2 milhões de homens: depressão HR 1,61; suicídio HR 1,22 (não significativo)
- Meta-análises recentes sem associação significativa
- Limite: homens de 50 a 90 anos, não de 30

Precaução sem alarmismo: com TOC, TDC ou humor frágil, a decisão é conjunta entre dermatologista e psiquiatra, com atenção ao humor nos primeiros 6 meses.

Fontes: Nguyen 2021; Lee 2025; Gupta 2025; JAMA Netw Open 2022; Fraenza 2026; Eur Urol Open Sci 2023.

Um encaminhamento duplo, em paralelo

Dermatologista ou tricologista

- Tricoscopia e diagnóstico da queda
- TSH, hemograma, ferro e rastreio metabólico
- Tratar feridas e escolher o remédio



Psiquiatra ou psicólogo

- Avaliar TDC, TOC e BFRB
- Conduzir HRT, ERP ou TCC
- Medicação e monitoramento do humor

Sinais de alerta pensamentos de morte · isolamento · ansiedade ou depressão crescentes · sono alterado · mudança de humor ou sexual após finasterida

Fontes: Taghizadeh 2026; Lauron 2023; ASAMI 2024; EMA.

Onde buscar ajuda no Brasil



188

CVV

Gratuito, 24 horas, todos os dias, com sigilo. Também chat e e-mail.



CAPS

Rede SUS

Centros de Atenção Psicossocial: acolhimento em saúde mental sem custo.



190 · 192

Emergência

Em risco imediato: pronto-socorro, Polícia Militar ou SAMU.

Se usa finasterida e passou a se sentir deprimido ou a pensar em morte: suspenda e procure o médico.

CONCLUSÃO

O gesto pesa mais que a calvície

- Tratar o ciclo de checagem antes de buscar o remédio ou o transplante "certo"
- Decidir queda e mente juntos: dermatologista e psiquiatra
- A quebra por atrito tende a regredir quando o gesto para

Principais referências

- Rück C et al. Body dysmorphic disorder. Nat Rev Dis Primers 2024
- Phillips KA, Menard W, Fay C. Compr Psychiatry 2006
- Ribeiro RVE. Aesthetic Plast Surg 2017 (TDC em dermatologia)
- Trüeb RM et al. Int J Trichology 2025 (tricoteiromania)
- Sánchez-Dueñas LE et al. Skin Appendage Disord 2021
- Farhat LC et al. Depress Anxiety 2020 (24 ECR)
- Grant JE et al. Arch Gen Psychiatry 2009 (N-acetilcisteína)
- Crerand CE et al. Psychosomatics 2005
- Huang CH et al. JAMA Dermatol 2021
- Kong et al. Front Psychiatry 2025
- Lauron S et al. JAMA Dermatol 2023 (alopecia areata)
- Acta Derm Venereol 2022 (síndrome metabólica)
- Nguyen DD et al. JAMA Dermatol 2021 (VigiBase)
- JAMA Netw Open 2022 (coorte sueca)
- EMA/PRAC 2025; ANVISA Alerta GGMON 7/2025
- FDA 2025 (finasterida tópica manipulada)